

Fecha Última Actualización: 13-07-2022 22:13:42

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Juliana Del Rosario Pacheco Ulloa
Edad : 56a 1m 2d
Dirección : El Lingue 02598 Lautaro Oporiente

Rut : 9.967.163-7
Fecha Nacto: 11/06/1966
Comuna : La Pintana

N° Archivo : A305913
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 6414 1132

N° Epicrisis
308398

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 13/05/2022 19:29

Días Estadía: 61

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 13/07/2022 22:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Informe de traslado ACTUALIZADO 13/07/22

Nombre: Juliana Pacheco Ulloa

RUT: 9967163-7

Edad: 55 años

Fecha de ingreso HSR: 13/05/2022

Fecha de ingreso UCI: 14/05/2022

Fecha de ingreso UTINCx: 02/06/2022

Fecha ingreso Sala CCEE: 10/06/2022

Antecedentes:

- Medicos: HTA, ICC, ACV dudoso previo, monorrena
- Quirugicos: nefrectomía
- Alergias (-)
- Hábitos: TBQ (-)

Motivo de consulta:

Compromiso de consciencia

Historia de ingreso:

Paciente última vez vista bien 13/05/22 a las 16:45. A las 17:00 presenta en forma súbita asimetría facial, compromiso de conciencia y vómitos explosivos. Ingres a el 13/05 al HSR, a las 17:56 con PAS 200 y se activa código stroke.

Al examen en sopor medio, mítica, no obedece órdenes, mirada preferente a derecha, hemianopsia der, PFC derecha, corneal disminuido a derecha, hemiparesia M2 der, Babinski derecha, equívoco izquierdo, impresiona hipoestesia der. En TAC de cerebro se observa HIP talámico izquierdo de 17cc con drenaje ventricular ICH 2. En angioTAC con spot sign. En Urgencia ingresa en Glasgow 8, muy hipertensa, se protege vía aérea, se inicia control de PA con labetalol + sedoanalgesia con meta de PA 180/110. TAC cerebral de control 22:30 hrs no muestra variaciones significativas con TAC previo. En el 14/05 evaluado por neurocirugía se decide instalar DVE , se realiza procedimiento

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS

Fecha Epicrisis : 13/07/2022 22:13

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:16

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 13-07-2022 22:13:42

Página 2 de 4

1. HEMODINAMICO: sin requerimiento de DVA. Con difícil manejo de PA, con necesidad de 6 anti-HTA orales y uso de urapidil + labetalol inicialmente. Posteriormente sólo con necesidad de anti-HTA orales y labetalol en dosis bajas. Se suspende sedación el día 18/05 y labetalol el 25/05. Posteriormente se maneja con amlodipino, carvedilol, hidralazina y losartán. Evoluciona normotensa. Actualmente estable.
2. VENTILATORIO: Paciente ingresa con ACV hemorrágico asociado a compromiso de conciencia por lo que se inicia VMI. Se realiza TQT el 23/05 dado que no se pudo extubar, sin complicaciones. Desde el 23/05 a las 18:15hrs con filtro, bien tolerado. Se instaló válvula de fonación y evoluciona con mala tolerancia, el 08/06 se IC a ORL que a su evaluación describe leve aducción de cuerda vocal izquierda. Se indica rehabilitación y seguimiento con fonoaudiología. Se mantiene en seguimiento por KNT y FNA, cursando con dos decanulaciones traumáticas durante hospitalización (en contexto de delirium y autoretiro de estas). Último episodio se decide no recanular por buena mecánica respiratoria y blue dye test reciente negativo. Actualmente con buena mecánica ventilatoria, sin requerimientos de oxígeno suplementario. Evaluada por ORL, no se recanulará de momento. Sin sintomatología respiratoria. En vigilancia.
3. NEUROLOGICO: ingreso por AVE hemorrágico ICH 2 con hidrocefalia que requirió instalación de DVE (13/05). El día 16/05 presenta movimiento clónicos generalizados que ceden con propofol. Por esto se inicia FAE. En TAC de control del 25/05 que muestra DVE in situ. Evoluciona favorablemente, el día 25/05 tiene episodios de mirada fija hacia abajo y nistagmus, por lo que se solicita EEG que resulta sin actividad epileptiforme. En TAC de cerebro del 01/06 con discreta disminución de hematoma. Evaluada por NCx se decidió realizar prueba de cierre por 48 horas. el 04/06 se retiró DVE y realiza TAC de control 07/06 que destaca tamaño ventricular similar. Por episodio comicial se maneja con levetiracetam (aprobado hasta el 12/07). Rehabilitación se mantiene con KNT M y R, además de fonoaudiología. Ha cursado con somnolencia de forma intermitente, mejor desde la semana pasada. TAC de Cerebro que no muestra mayores cambios en relación a estudio previo. Probablemente determinado por presencia de fatiga asociada a alto uso de VF y componente de delirium sobreagregado de causa tóxica metabólica. Se solicita evaluación por neurología para eventual traslado a neurología para continuar con rehabilitación, indicando presentarla a HSJM u otro centro de rehabilitación integral. Se harán los esfuerzos por recuperar funcionalidad suficiente para poder derivar a neurorehabilitación UHD HPH, se actualiza informe de traslado. Actualmente con mejoría del estado de vigilia, intensificando rehabilitación.
4. Infeccioso: Múltiples hits infecciosos, el último NAVM y bacteremia por Serratia Marcescens. Se trató con Meropenem hasta el 14/06. Luego traqueitis, se inicia empíricamente meropenem, con CAET M. Morganii y S. Mercens. Sin antibióticos de momento, PII a la baja. Si fiebre pancultivar y esperar a resultados de cultivos para inicio de antibioterapia específica de estar estable. Si febril e inestable, iniciar Vancomicina + Meropenem de forma empírica. Parámetros inflamatorios bajos actualmente.
5. Cardíaco: Historial de ICC, ecocordio determina defecto CIA tipo OS. Evaluada por cardiología, determinan necesidad de ampliar estudio con Ecocardiografía TE + eco doppler eeii (p) como fuente tromboembólica. Eco TE se realizará de manera ambulatoria.
6. Nefrológico: Curso con hiponatremia recuperada. Sin falla renal ni alteraciones HE. Estable.
7. Metabólico/Nutricional: De momento con aporte de Fresubin a 80 ml/h por presencia de trastorno de deglución asociado a patología de base. A la evaluación dirigida por FNA, impresiona apraxia deglutoria por sobre trastorno de deglución severo fijo, por lo que requiere rehabilitación intensa en este momento, donde tiene el mayor potencial de recuperabilidad. Del punto de vista metabólico, sin requerimientos de insulina de momento. Con esquema para meta glicémica bajo 200 por estar con NE continua. Se ha estado educando a familiar para continuar con rehabilitación en domicilio.
8. Ginecológico: Presentó dermatitis de pañal, resuelta.
9. Rehabilitación: En seguimiento por FNA y KNT. Mejoría progresiva de control motor. Buen control de cuello y buen control de tronco el que mejora progresivamente.
10. Profilaxis: Enoxaparina por Buena función renal.

Se intentará la posibilidad de egreso con UHD HPH para neurorehabilitación, entendiendo que rehabilitación de la paciente está muy condicionada por el estado de ánimo de la paciente. En este contexto, se autoriza conjunto a fonoaudiología a familiar asistir en la alimentación. Con buena respuesta a la estimulación con familiar.

Manejo: Activo

Diagnósticos de traslado:

1. Hemorragia Intraparenquimatosa talámica izquierda con Volcado Ventricular
 - a. ICH 2
 - b. Hipertensivo
 - c. DVE retirado 04/06

Fecha Epicrisis : 13/07/2022 22:13

Página 2 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:16

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 13-07-2022 22:13:42

Página 3 de 4

2. Obs CIA tipo OS
3. Traqueitis por Morganella Morganii y S. Mercencens
 - a. Meropenem 5/5
4. Crisis epiléptica 25/05
5. TQT 23/05
 - a. Decanulación traumática y reanulación de urgencia 13/06
 - b. Cambio de cánula 16/06
 - c. Decanulación traumática sin reanulación 30/06/2022
5. Disfagia Fils 4.

Diagnóstico de Egreso

Accidente Vascular Hemorrágico (Hic) -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente clínicamente estable en fase de rehabilitación.

Hemodinámicamente normotensa, normocárdica. Afebril. Sin requerimientos de oxígeno suplementario. Sin sintomatología respiratoria sobreagregada.

Se conecta con el medio de forma atingente. No acusa dolor ni molestias.

En seguimiento por fonoaudiología y por kinesiólogo.

Mantiene elementos de apraxia deglutoria por sobre un trastorno de deglución severo; por lo que se encuentra en fase de máximo potencial de recuperabilidad. Familiares asistiendo para trabajo con fonoaudiología. En plan de egreso con UHD HPH.

Control de exámenes sin trastorno hidroelectrolítico. Parámetros inflamatorios bajos.

Plan Post Alta

Reposo relativo asistido estricto, cabecera 30-45° al acostarse

Regimen:

Familiar otorgue alimento en cosistencia papilla para promover ingesta oral (autorizada por equipo médico).

Sentada en 90°

Pausado

Seguimiento por fonoaudiología

Rehabilitación: KNT, FNA y TO

HGT c/6 hrs; IC según HGT y esquema

Amlodipino 5 mg día por SNG

Carvedilol 12,5 mg cada 12 hrs por SNG

Hidralazina 100mg cada 8 hrs por SNG

Losartan 25 mg cada 12 hrs por SNG

Levetiracetam 500mg cada 12 hrs por SNG

Risperidona 1 mg PM por SNG

Bromuro de ipatropio 2 puff cada 6 horas por AEC

Atropina 1 mg en 10 cc SF, 0.1 mg c/8 hr por SL

Ecocardiograma transesofagico en ambulatorio en CASR para evaluación de CIA

Manejo: Activo

Indicaciones

Tipo de Reposo : Levantar A Sillon

Régimen Alimentario : Nutrición Enteral

Medicamentos :

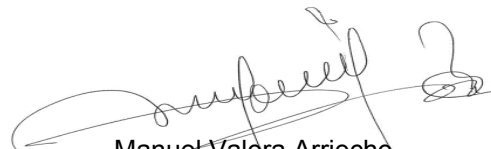
Fecha Epicrisis : 13/07/2022 22:13

Página 3 de 4

Controles

INTERNO

Elías Valenzuela Saavedra
Becado/Residente



Manuel Valera Arrieche
Médico Tratante (Staff)